Diskussion 1745

Datum: 1927-05-25
Kammare: Andra kammaren
Antal yttranden: 2
Källa: Tal om Kvinnor: Annotated Corpus, byggd på The Swedish Parliament Corpus (Yrjänäinen m.fl. 2024).
Projekt: https://github.com/DigitalHistory-Lund/ToK-Preparer
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.18211787
Version: 2026.10.14

Markerade ord: ¹ kvinna-ord, ² släktskaps- och tilltalsord, ³ yrkestitlar.

1. Bernhard Eriksson (Socialdemokraterna, man)

Herr talman! Jag lovar att fatta mig mycket kort, men jag måste dock säga några ord med anledning av vad, som förekommit under debatten.

Herr Laurén påtalade, att de sakkunniga och Kungl. Maj:t och utskottet gått in för ett förslag, som medger enbart sjukvårdsförsäkring. Med anledning av vad herr Laurén i det avseendet anförde, vill jag säga, att den ifrågavarande bestämmelsen ingalunda tillkommit för att de unga männen i allmänhet skola kunna försäkra sig på det sättet. Det trodde icke de sakkunniga skulle komma att ske. Utan bestämmelsen har tillkommit för att möjliggöra för t. ex. en arbetare att kunna försäkra sin **hustru²** för sjukvård. Vi ha ekonomiskt svagt ställda medborgare, som mången gång inte ha råd att taga en sjukförsäkring, som medger såväl sjukpenning som sjukvård för både mannen och **hustrun²**. Man har då resonerat så, att mannen kan försäkra sig för både sjukpenning och sjukvård, men att möjlighet bör beredas honom att därjämte försäkra **hustrun²** för enbart sjukvård. Förslaget innebär, att man också kan försäkra barnen

för sjukvård. Barn äro förbjudna att tillhöra sjukkassa för sjukpenning, men Ang.

de kunna tillhöra sjukkassa för sjukvård, om kassan det vill. Det kan alltsäd sen ordnas så, att hela familjen blir försäkrad för sjukvård. Det är sålunda ett jassor nn ganska bra förslag i sjukvårdshänseende, det torde herr Laurén inte kunna = (Forts.) förneka.

Vad som närmast föranledde mig att begära ordet, var det anförande, som hölls av herr Andersson i Igelboda. Han har, såvitt jag förstår, alldeles missuppfattat förslaget. Han säger, att det finns mycket goda förhoppningar, att rikssjukkassorna skola sammansluta sig till en, att arbete i den riktningen pågår och att allt då kommer att ordnas upp. Ja, om så vore, så skulle det vara synnerligen lyckligt. Nu är jag för min del pessimist i den punkten. När inte rikssjukkassorna i fjol ville vara med om Kungl. Maj:ts förslag, som innebar, att de skulle fått nästan halva Sverige ensamma för sin del, om de sammanslutit sig, när de inte ansågo sig kunna klara den historien, då tror jag inte, att de frivilligt skola göra det. Herr Andersson i Igelboda har en annan uppfattning. Jag har min. Vi få se, vem som får rätt. Varför jag har

denna uppfattning, skall jag inte gå in på; det kunna vi tala om en annan gång. Men skulle nu så bli, att de sammansluta sig, då blir det, säger herr Andersson i Igelboda, en underlig organisation. Vi få en rikssjukkasseavdelning, som skall lämna sjukpenning för 100 dagar, och vi få en distriktssjukkassa, som skall lämna sjukpenning från 100 dagar till 2 år. Emellertid, distriktssjukkassorna bliva på många ställen ganska små och svaga, så att de behöva återförsäkra. Skulle nu så bli, att rikssjukkassorna sluta sig samman, så är det enligt min mening visst naturligt, att på de platser där inga lokalkassor finnas rikssjukkasseavdelningen bliver både bottenkassa och distriktskassa. Och då är saken ordnad. Jag kan inte förstå annat, än att man på det sättet löser svårigheten mycket enkelt, om rikssjukkassorna sammansluta sig. Då kan den nya rikssjukkassan även vara återförsäkringskassa åt distriktssjukkassan.

Sedan var det tal om de sjuka och gamla sjukkassemedlemmarnas ställning. Jag medger, att när det gäller de sjuka var fjolårets förslag effektivare och hättre än detta. Det kan inte förnekas. De sakkunniga ansågo i höstas och Kungl. Maj:t likaså, att man, när det gäller att få till stånd en frivillig sammanslutning, inte kan ålägga distriktssjukkassorna att taga emot de redan sjuka medlemmarna från primärkassorna och ge dem den långa sjukhjälpstiden. Vid en tvångsvis åstadkommen sammanslutning kan man säga, att de måste det, men att staten i gengäld skall ge större bidrag för att utjämna kostnaderna. Men utan ett sådant extra bidrag av staten är det omöjligt att ålägga distriktskassorna att taga emot lokalavdelningarnas sjuka medlemmar. Jag hoppas nu för min del, att denna fråga kommer att lyckligt ordnas i framtiden, och den kommer säkert att ordnas bättre, om sammanslutning kommer till stånd, än med nuvarande förhållanden. Ty då har man en organisation, och staten kan genom extra anslag uppmuntra till att ge de före den nya organisationen redan sjuka medlemmarna en längre sjukhjälp än de nu få. Deras ställning, det betonar jag, blir i varje fall inte sämre, än den nu är. Herr Andersson i Igelboda säger emellertid, att den blir sämre, därför att de små kassorna komma att försvinna. De komma att inte få någon nyrekrytering, och medlemmarna bli gamla, så att de inte kunna komma in i en distriktssjukkassa, och de allra äldsta komma att ingenting få. Men jag vill fråga herr Andersson i Igelboda: om inte organisationen kommer till stånd, hur går det då med de små sjukkassorna? Omkring 10 procent av sjukkassorna ha inte haft någon nyrekrytering på de senaste 3—4 åren. Vad visar det? Det visar, att de äro på väg att stagnera. Jag kan som exempel nämna en sjukkassa i mitt eget län. Den har omkring 150 medlemmar, och deras medelålder utgör 57 år. Tror herr Andersson, att dessa medlemmar få mycket av den kassan. Då medelåldern är

27 år, så är det tydligt, att en stor del av medlemmarna äro uppe i 70 å 80 år. Hur går det med den kassans medlemmar utan denna omorganisation? Om de ha några fonder och så länge de räcka, kunna de ju få litet understöd, men sedan är det slut. Det är alltså inte bättre ställt för närvarande, än vad det blir om förslaget antages. Om nu kassorna äro förståndiga och slå sig tillsamman, så kunna ju kommunerna uppmuntra detta, såsom skedde i Eskilstuna. Där var det omkring 30 små kassor. En del av dessa hade ingen nyrekrytering och gamla medlemmar. Då förklarade stadsfullmäktige, att om kassorna sammanslöte sig skulle de få 3 kronor per år och medlem i kommunalt bidrag. Och på det viset fick man till stånd den bästa

sjukkassa, vi ha i vårt land. Så komma naturligtvis kommunerna, att göra på många håll. J a, även staten kan träda till, när vi få se, hur denna organisation kommer att gestalta sig, och ge extra bidrag för att befordra sammanslutningen. Men göra vi ingenting åt detta, då äro i varje fall de små kassorna dömda att gå under. Någon nyrekrytering få de inte heller under nuvarande förhållanden, det måste herr Andersson 1 Igelboda medgiva.

Fru² Nordgren frågade, hur det skulle gå för vissa gamla, som tillhöra fortsättningskassor. Jag är inte jurist, men jag tolkar förordningarna efter mitt lekmannasätt att se. Vi kunna tänka oss, att i en stad för närvarande finnas flera bottenkassor och en fortsättningskassa. Bottenkassan lämnar sjukhjäp för 180 dagar och fortsättningskassan för 180 dagar, så att det tillsammans blir ett år. Om nu fortsättningskassan blir distrikssjukkassa, vilket bör vara det naturligaste, så är det ingen tvekan om att den måste taga med alla medlemmar som nu tillhöra fortsättningskassan, både friska och sjuka, både unga och gamla. Fortsättningskassan kan inte, såvitt jag förstår, när den omskapas Ull distriktssjukkassa, utelämna några medlemmar. Det är därför helt naturligt, att fortsättningskassan omskapas till distriktssjukkassa, och därmed är saken ordnad.

Hur ställer det sig med förvaltningskostnaderna? Hur stora komma dessa att bliva? Att det blir något ökade kostnader, kan inte bestridas. Men mycket beror på, hur praktiska människorna äro på de olika platserna. Om man på en ort har några bottensjukkassor och en distriktssjukkassa, så skola ju medlemmarna i bottensjukkassorna tillhöra distriktssjukkassan. Är man då praktisk, så kan man ordna det så, att distriktssjukkassan tar upp avgifterna genom bottensjukkassorna. Man kan alltså ha en enda uppbörd, och man kan också ordna det med gemensam expedition och med sammanlöpande verksamhet i största möjliga utsträckning. Nog kan man ordna denna sak, utan att det behöver bli allt för vidlyftigt. Men att det blir något ökade kostnader med denna dubbelorganisation, det kan som sagt icke förnekas. Det föreliggande förslaget är ingen idealisk lösning, men vi få taga den ändå och se till att vi förbättra den sedan allt efter erfarenheten. Blir jag kvar:i riksdagen, så nog skall Jag vara med om att se till, att rättelse kommer att vidtagas, där så visar sig vara behövligt. Vad nu kostnaderna beträffar talade herr Andersson i Tgelboda om »Vänfast» i Stockholm som ett exempel på hur det går med en sammanslagningskassa. Jag tycker, att herr Andersson i Igelboda bort peka på Eskilstunakassan, som verkat i över 20 år. J ag tycker, att den sammanslagningskassan i stället bör tagas som förebild. Den senaste statistiken angående sjukkassornas förvaltningskostnader är från år 1924. Nämnda år utgjorde förvaltningskostnaderna för Eskilstunakassan 3 kronor 2 öre per medlem. TIen av Sveriges bäst skötta rikssjukkassor var samtidigt förvaltningskostnaden 3 kronor 33 öre per medlem, och ändå ha lokalavdelningarna särskilda avgifter för den lokala förvaltningen. Det förhåller sig inte så, att rikssjukkassorna ha den billigaste organisationen. Det kan ingen påstå. Vi ha rikssjukkassor, där förvaltningskostnaderna åtskilligt överstiga 3 kronor 33 öre, ja, gå upp till om-

kring 4 kronor. Det är tydligt att det kan bli ökade förvaltningskostnader, =: Ang. men det

gäller naturligtvis för medlemmar att se till, att så mycket som möj-Jöroråning om ligt hålla kostnaderna nere. Skall man bygga på självverksamhet, så får man Tassor ER ha en smula förtroende för att sjukkassemedlemmarna själva, var och en i sin — (Forts) stad, göra sitt bästa i detta avseende.

Nu har flera olika yrkanden framställts. Det har framhållits av herr statsministern, att mina farhågor för att det skulle kunna komma att bli slutna distriktssjukkassor på platser, där endast slutna primärkassor finnas, skulle vara obefogade och om så skulle bli fallet kunde det rättas till sedan. Den saken skall jag inte nu närmare diskutera. Jag tror, att min uppfattning är riktig. Jag vidhåller därför, att kammaren gör bäst i att följa utskottet, så att vi kunna få en sammanjämkning mellan första kammarens och andra kammarens linjer 1 denna fråga.

Nu har ju även yrkats avslag å förslaget från flera håll. Jag säger, såsom jag förut sagt, att jag kan förstå, att man är missnöjd med detta förslag. Men vi få väl i alla fall taga hänsyn till de svårigheter vi haft att få till stånd en omorganisation, och vi få väl tänka oss, att framtiden skall ge oss möjlighet att förbättra vad vi i kväll, såsom jag hoppas, genomföra. Jag tror för min del, att det skulle vara oklokt av andra kammaren att avslå utskottets förslag i den förevarande paragrafen och därmed lagen i dess helhet.

Jag ber därför, herr talman, att fortfarande få yrka bifall till utskottets förslag i den nu föredragna paragrafen.

2. Jakob Pettersson (–, man)

Herr talman! Det är en brokig mängd av olika meningar, som framträtt i denna fråga. Först ha vi en, som jag hoppas, icke alltför liten falang av kammaren, som verkligen vill ha till stånd en reform snarast möjligt av den frivilliga sjukförsäkringen och vill bereda denna försäkring ett avsevärt bättre understöd från statens sida. I denna grupp finns det emellertid somliga, som föredraga Kungl. Maj:ts förslag, och andra, som föredraga utskottets förslag. Det är så mycket talat om skiljaktigheten mellan de grupperna, att jag icke skall säga något mera om den saken, än att skillnaden mellan dem, beträffande särskilt 11 $, verkligen, om herrarna vilja tänka på saken en gång till, inte är synnerligen stor. Jag vill hoppas, att de, som i alla fall vilja ha en reform till stånd på vare sig den ena eller andra av dessa linjer, dock äro så till vida ense, att de vilja offra något för, att få ett resultat till stånd i år.

Ä andra sidan är det åtskilliga av kammarens ledamöter, som vilja rösta för avslag. Även bland dem råda olika meningar. Först ha vi somliga, som inta en rent negativ ståndpunkt därför att de tycka, att det är synd, att staten skall använda så mycket pengar på att understödja sjukförsäkringen. Vidare ha vi andra, som yrka avslag, därför att de tycka, att sjukkassorna skulle bli alltför byråkratiska inrättningar, och som därför i stället vilja lägga sjukvårdsförsäkringen i pensionsstyrelsens händer. Andra åter äro rädda för att förslaget går för hänsynslöst fram över rikssjukkassorna, och av dem är det somliga, som tro, att om detta förslag nu faller, det skall bli lättare att på frivillighetens väg få till stånd enhetlighet inom sjukkasseväsendet. D. v. s. den mångfald av olika meningar, som under de föregående

månaderna yppat sig i denna fråga, skulle blåsa bort, och det skulle bli frid och enhetskassesystem frivilligt inom sjukkasserörelsen. Slutligen finns det somliga, som yrka på avslag, i hopp om att vi därigenom i stället skulle komma fram till obligatorisk sjukförsäkring.

Nu vill jag kasta upp frågan: Vilken av de fyra olika avslagsgrupperna tro

då **damerna**[2] och herrarna har de bästa utsikterna att få sin vilja igenom i fortsättningen, ifall det blir avslag i kväll? Jag vill då fästa uppmärksamheten på att för närvarande diskuteras på den internationella arbetskonferensen i Geneve frågan om sjukförsäkringen. Det göres ganska stora ansträngningar för att där få fram ett förslag till konvention om obligatorisk sjukförsäkring. Det lider intet tvivel, att de flesta stater luta åt den obligatoriska försäkringen. Det finns åtskilliga, som icke vilja ha dem, men de torde vara i minoritet. Om nu riksdagen i år beslutar sig för en frivillig sjukförsäkring med understöd från staten, lär det väl vara ganska visst, att då få vi, jag höll på att säga, i lugn och ro ordna vår frivilliga sjukförsäkring, såsom riksdagen finner lämpligt. Men skulle resultatet bli, att förslaget om den frivilliga försäkringen faller, är det alldeles uppenbart, att mycket starka krafter komma i verksamhet för att snarast möjligt driva oss till obligatorisk sjukförsäkring.

Om sålunda det nu blir avslag, lider det knappast tvivel, såvitt jag förstår, att de, som vilja komma fram till obligatorisk försäkring, hava vunnit spelet med hjälp av de andra grupperna, som ha andra program för framtiden. De som nu verkligen vilja komma till en så genomgripande reform, som det är oss möjligt att genomföra i år, tror jag emellertid göra klokt i att nu söka samla sig om parollen: ett positivt beslut detta år.

Det har sagts under diskussionen, att rikssjukkassorna skulle kanske, ifall det nu bleve ett bifall till vare sig utskottets eller Kungl. Maj:ts förslag, söka reda sig för framtiden utan statsbidrag och ordna sig utan statens inblandning. Det tror jag är en förutsägelse, som icke skulle komma att slå in, ty först och främst är i alla fall det statsbidrag, som här ifrågasättes, så pass ansenligt, att kassorna nog tänka sig för mer än en gång, innan de alldeles avstå därifrån. För övrigt är jag övertygad, att rikssjukkassorna skola komma att ställa sig lojala till det beslut, riksdagen fattar, och att de skola väl förstå att anpassa sig efter den nya ordningen. De skola säkerligen finna sig väl till rätta med densamma och få tillfälle till vidare utveckling av sin verksamhet.